EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93722
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-29 10:36:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALICIA DE JESUS MARIN GUTIERREZ			RUN	: 7.271.052-5
F.Nac	: 18-04-1953	Edad	: 71 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: 11 SEP.PATAGUAS 875 ACT.			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 923604413		
Fecha Ingreso	: 2024-09-26	Fecha Egreso	: 2024-09-29 10:36:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-INFECCION DEL TRACTO URINARIO X E. C0LI MS
2-NAC
3-ANTECEDENTES: HTA, DMNIR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente autovalente, vive sola, con antecednetes de HTA, DM, ARTROSIS en tratamiento con tramal 1c/72 hrs, celecoxib 200mg c/72hrs, paracetamol 2 comp c/12hrs, furosemida 40mg por dia, enalapril 1 c/12hrs, NPH26U-20U, Metformina 1-1. cx: cesarea (4), colecistectomizada. Consulta en M2, por CEG, diaforesis, inapetencia, refiere cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por vomitos y diarrea, a la llegada al domicilio destaca hgt; 72mg/dl, febril 37.9, taquicardica, saturando 94% ambiental. Ingresa acompañada por vecina, en regulares condiciones generales, regular hidratacion, mucosas y piel palidas, PIRRL, yugulares planas, ventilando espontaneo, ABDI, refiere dorsalgia a derecha, niega dolor abdominal y niega sintomas respirarorios, bien perfundida a distal, piel tibia, edema –
Rx Torax Ap Y Lateral: Condensación Basal A Derecha. Paciente ingresa con manejo de ATB de primera linea . posteriormete se recibe Urocultivo que reporta E. coli MS por lo que se mantienen Antibioticoterapia. Paciente durante hospitalizacion se mantiene con Hemodinamia estable con descenso de Parametros inflamatorios. Para el dia de hoy hemodinamicamente estable , afebril con parametros inflamatorios moderadamente altos por lo que se plantea HODOM para completar ATB.

PLAN DE MANEJO:

manejo x HODOM x 4 dias para completar ATB y posterior hacer traslape de ATB via oral .

INDICACIONES AL ALTA

1. 1-Ceftriaxona 2g ev dia x 4 dias
2. 2-Omeprazol 20mg via oral una vez al dia
3. 3-Bromuro ipatropio 4 puff c/8 horas C/AEC
4. 4-Atorvastatina 20mg una vez al dia
5. 5-Metformina 850mg c/8h
6. 6-vildagliptina 50mg una vez al dia
7. 7-Paracetamol 1g via oral cada 8 horas si presenta dolor

EXÁMENES Y RESULTADOS

ver historia

jesus luis antonio perez lozada
MEDICO TRATANTE
26918952-5

JEFE SERVICIO